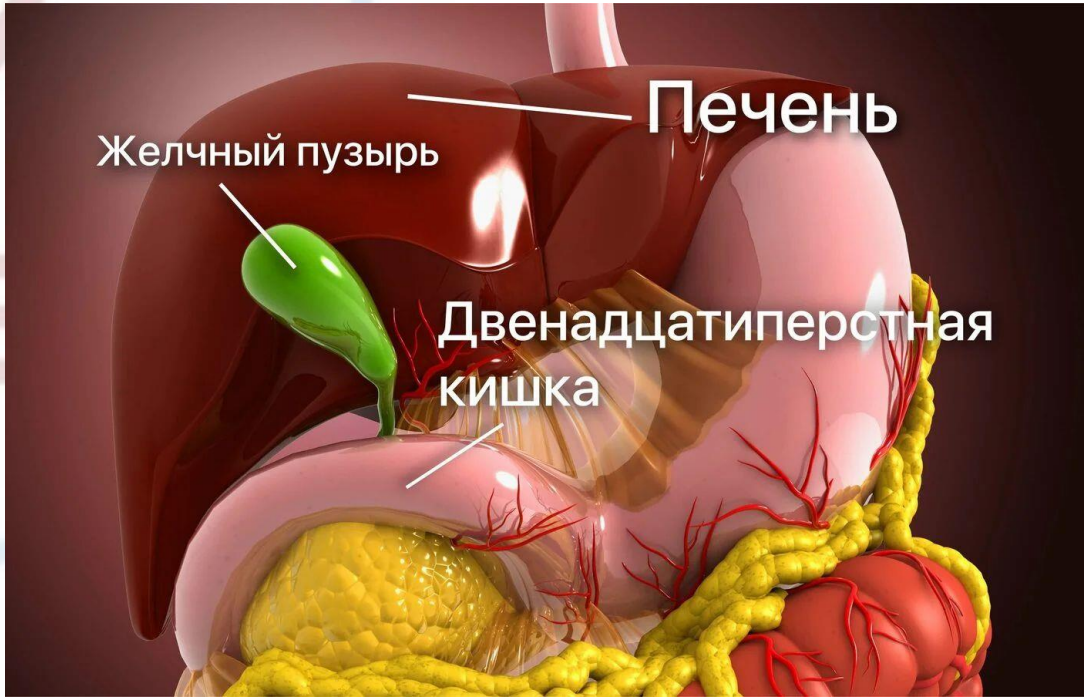


Желчный пузырь

Желчный пузырь (Vesica fellea)

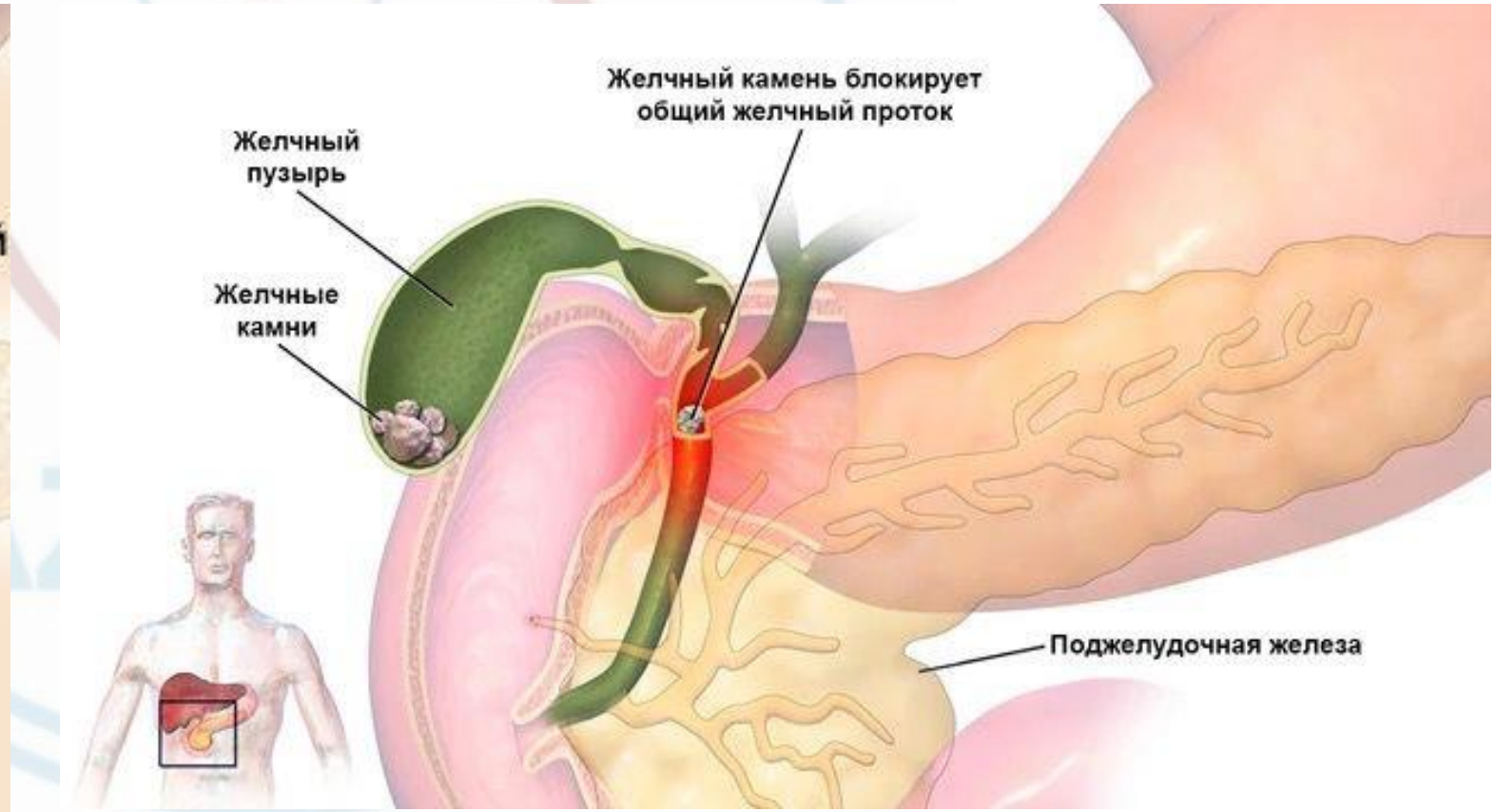
Желчный пузырь — это полый грушевидный орган, входящий в билиарную систему. Он расположен на висцеральной поверхности печени. Основная функция желчного пузыря — накопление, концентрация и периодическое выделение желчи в двенадцатиперстную кишку. Длина 7–10 см. Ёмкость 40–70 мл.

Желчь — это биологически активная жидкость желтовато-зелёного цвета, с горьким вкусом и слабощелочной или нейтральной реакцией. Она вырабатывается клетками печени — гепатоцитами — и играет важную роль в процессе пищеварения.Желчный пузырь расположен на нижней поверхности печени и тесно прилегает к ней. Его основная функция заключается в накоплении, концентрации и периодическом выделении желчи в двенадцатиперстную кишку.Различают два вида желчи: *печёночную и пузырную.* Печёночная желчь образуется в печени, имеет светлый цвет, жидкую консистенцию и менее концентрированный состав. Она участвует преимущественно в переваривании малокалорийной пищи.Пузырная желчь накапливается в желчном пузыре, имеет тёмный цвет, густую консистенцию и высокую концентрацию желчных кислот, билирубина и холестерина. Она участвует в переваривании жирной и высококалорийной пищи.



Желчь выделяется не постоянно, а преимущественно во время пищеварения. В межпищеварительный период она накапливается в желчном пузыре. При длительных перерывах между приёмами пищи, нерегулярном питании и употреблении сухой пищи возникает застой желчи. Застой желчи со временем приводит к развитию воспалительного процесса в стенке желчного пузыря и способствует образованию желчных камней. Основной причиной камнеобразования считается нарушение обмена холестерина и повышение его концентрации в желчи.Радикальным методом лечения желчнокаменной болезни является хирургическое удаление желчного пузыря. Данная операция называется ***холецистэктомия***





Заболевания желчного пузыря

Желчнокаменная болезнь (холелитиаз) — это хроническое заболевание, характеризующееся образованием камней в желчном пузыре и (или) желчных протоках. Заболевание может развиваться на фоне наследственной предрасположенности, повышенного содержания холестерина, застоя желчи и инфекционных процессов.

Симптомы:

Боли в правом подреберье, усиливающиеся после приёма жирной пищи
Иррадиация боли в правое плечо, лопатку или шею
При обострении — тошнота, рвота, озноб, повышение температуры тела

Дискинезия желчевыводящих путей — это функциональное нарушение сократительной способности желчного пузыря и желчных протоков. Может развиваться при нерегулярном питании, длительных перерывах между приёмами пищи, а также при заболеваниях нервной системы.

Симптомы:

Тянущие или приступообразные боли в правом подреберье
Чувство тяжести и дискомфорта
Нарушения стула — чередование запоров и диареи

Холецистит — это воспалительное заболевание желчного пузыря. В 90 % случаев развивается на фоне желчнокаменной болезни.

Симптомы:

Резкие или постоянные боли в правом подреберье
Тошнота, рвота
Повышение температуры тела
Возможное потемнение мочи и кожный зуд при нарушении оттока желчи

Основные методы диагностики

Лабораторные исследования: Общий анализ крови/мочи, биохимия (билирубин, печеночные ферменты, щелочная фосфатаза) для выявления воспаления.

УЗИ органов брюшной полости (УЗИ): Основной метод, визуализирующий камни (от 3 мм), состояние стенок и диаметр протоков.
МРТ/КТ: Компьютерная и магнитно-резонансная томография, рентген с контрастом для детальной оценки протоков, при подозрении на осложнения.
Дуоденальное зондирование: Анализ желчи для определения инфекции.

Лечение заболеваний желчного пузыря

Консервативная терапия (на ранних стадиях, бескаменный холецистит)
1. *Диета:* Дробное питание (5-6 раз в день), ограничение жирного, жареного.
2. *Препараты:* Спазмолитики (для устранения колик), желчегонные, антибиотики (при инфекции).
3. *Литолитическая терапия:* Растворение мелких холестериновых камней препаратами урсодезоксихолевой кислоты (УДХК).

Хирургическое лечение (основной метод при ЖКБ):
Холецистэктомия: Удаление желчного пузыря (чаще всего лапароскопическим методом через проколы).
Показания: Наличие крупных камней, частые приступы желчной колики, признаки воспаления (холецистит), полипы (более 1 см).